



Material de Consulta

Anamnese:

- **Desenvolvimento:**

- Peso e Altura:
 - RN → 6m → 1a → 2a → 5a → 10a...
 - Registrar perdas ou ganhos:
- Idades que atingiu marcos:
 - Seguiu com olhar:
 - Manteve pescoço ereto
 - Sorriu de volta:
 - Segurou e transferiu objetos das mãos:
 - Deambulação:
 - Fala:
- Erupção dentária:
- Idade de independência para atividades cotidianas:

- **Imunização:**

- Vacinas administradas:
- Reações:
- Cartão de vacinas:
- ATENÇÃO: Se realizado o Teste do Pezinho ampliado, é razoável aguardar o resultado para administração da BCG!

Suplementação

Sulfato Ferroso (125mg/ml)

- 1mg/kg, VO, 1x/dia, em 2 ciclos (1º dos 6 aos 9 meses; 2º dos 12 aos 15 meses)
 - Obs1: Iniciar aos 3 meses se fator de risco materno:

- Anemia gestacional, doença disabsortiva, parto difícil com sangramento ou clampeamento precoce.
- Obs2: Frutas cítricas ajudam a absorção e produtos lácteos atrapalham.
- Obs3: 125mg/ml de sulfato = 25mg/ml de ferro = 20 gotas

Vitamina D:

- Apresentação varia: 200 UI/gota, 400, 600, 1000, 2000...
- Indicações
 - RN a 01 ano → 400 UI/dia;
 - 01 ano a 18 anos → 600 UI/dia;

Zinco:

- Indicado em prematuros < 32 sem. até os 6 meses

Megadose de Vit. A:

- Posologia:
 - Aos 6 meses → 100.000 UI;
 - A cada 6 meses até completar 60 meses → 200.000 UI;

Exame Físico:

1. Antropometria e Puericultura:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • Peso: | • Classificações |
| • Estatura: | ◦ Z-Zcore Peso/Idade: |
| • PC: | ◦ Z-Score Altura/Idade: |
| • IMC: | ◦ Z-Score Peso/Altura: |
| • Avaliação alimentar: | ◦ Z-Score IMC/Idade: |
| ◦ Adequada ou inadequada? | ◦ Z-Score PC/Idade: |
| ◦ Erro qualitativo ou quantitativo? | ◦ Classificação nutricional: |
| • Imunização: | • DNPM: |
| ◦ Em dia ou em atraso? | ◦ Adequado para a idade? |

2. Sinais Vitais:

- FC:
- PA (a partir de 3 anos):
- FR:

- SpO₂:
- T_{ax} (°C):

3. Geral:

- **Estado geral:**
- **Fácies:**
- **Postura e atitude:**
- **Estado psíquico:**

- **Nutrição e hidratação:**
- **Malformações congênitas visíveis:**
- **Reação ao examinador e aos pais**
- **Avaliar fontanelas;**

4. Pele

- Coloração da pele
- Manchas, lesões, cianose ou icterícia?

- Mucosas normocoradas?
- Pescoço; linfonodos elásticos, móveis

5. Olhos

- Reflexo fotomotor:
- Fixação e seguimento:
- Reflexo vermelho (Brückner):

- Estrabismo:
- Nistagmo:

6. Ouvidos, Nariz e Garganta:

- Pavilhões auriculares:
- Otoscopia:
- Nariz:
- Orofaringe:

- Amígdalas:
- Dentição (nº de dentes):
- Higiene oral:
- Frênulo lingual:

7. Cardiovascular

- BRNF 2T?
- Sopros?

- TEC:
- Assimetria de pulso?

8. Respiratório

- Formato do tórax:
- MV bem distribuídos?

- Uso de mm. acessória?
- Expansibilidade preservada e simétrica?
- Som claro pulmonar à percussão?

- Ruídos adventícios?
- Taqui ou bradipneia?

9. Abdome

- Sintoma gastrointestinal?
- Formato:
- Coto umbilical (RN):
- Hérnias?
- RHA presentes e normoativos?

- Sopros?
- Timpanismo à percussão?
- Dor à palpação?
- Alguma visceromegalia?

10. Genitália e ânus:

a) Masculino:

- Testículos:
- Hidrocele:
- Hipospádia:

- Ânus:
- Sinais de violência/abuso:
- Tanner Masculino: GxPy

Estágios de desenvolvimento da genitália



Estágio 1

Genitália pré-puberal ou infantil.



Estágio 2

Aparece um afinamento e hipervascularização da bolsa escrotal, e aumento do volume testicular sem aumento do tamanho do pênis. (G2)



Estágio 3

Ocorre aumento da bolsa escrotal e do volume testicular, com aumento do comprimento do pênis. (G3)



Estágio 4

Maior aumento e hiperpigmentação da bolsa escrotal, maior volume testicular com aumento do pênis em comprimento e diâmetro, e desenvolvimento da glândula. (G4)



Estágio 5

Genitália adulta em tamanho e forma e volume testicular. (G5)

Estágios de desenvolvimento dos pelos pubianos



Estágio 1

Pelugem pré-puberal ou infantil, nenhum pelo pubiano. (P1)



Estágio 2

Ocorre o início do crescimento de alguns pelos finos, longos, escuros e lisos na linha medial ou na base do pênis. (P2)



Estágio 3

Aparecimento de maior quantidade de pelos, mais escuros e mais espessos, e discretamente encaracolados, com distribuição em toda a região pubiana. (P3)



Estágio 4

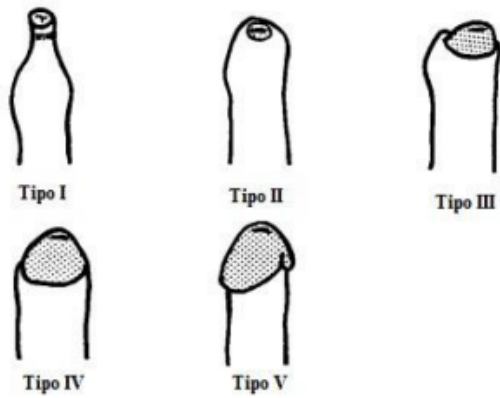
Pelos escuros, espessos, encaracolados, do tipo adulto, mas ainda em menor quantidade na sua distribuição na região pubiana. (P4)



Estágio 5

Pelos do tipo adulto, em maior quantidade, cobrindo toda a região pubiana, e estendendo-se até a superfície interna das coxas. (P5)

- Fimose? Classificação de Kayaba



Fonte:: Hirowki Kayaba (1996, p. 1).

Analysis of shape and retractability of the prepuce in 603 Japanese boys.

b) Feminino

- Sinéquia de pequenos lábios:
- Secreções:
- Ânus:
- Sinais de violência/abuso:
- Tanner Feminino: MxPy

Estágios de desenvolvimento das mamas



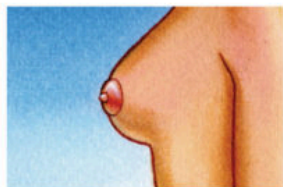
Estágio 1
Mamas infantis (M1)



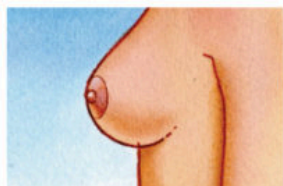
Estágio 2
O broto mamário forma-se com uma pequena saliência com elevação da mama e da papila e ocorre o aumento do diâmetro areolar. Melhor visualizar lateralmente. (M2)



Estágio 3
Maior aumento da aréola e da papila sem separação do contorno da mama. (M3)

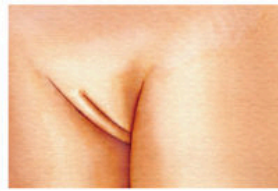


Estágio 4
Aumento continuado e projeção da aréola e da papila formando uma segunda saliência acima do nível da mama. (M4)



Estágio 5
Mama com aspecto adulto, com retração da aréola para o contorno da mama e projeção da papila. (M5)

Estágios de desenvolvimento dos pelos pubianos



Estágio 1
Ausência de pelos, ou pelugem natural. (P1)



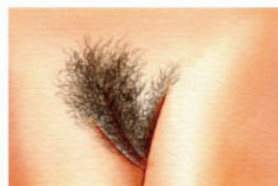
Estágio 2
Pelos iniciam-se com uma pelugem fina, longa, um pouco mais escura, na linha central da região pubiana. (P2)



Estágio 3
Pelos em maior quantidade, mais escuros e mais espessos, e discretamente encaracolados, com distribuição em toda a região pubiana. (P3)



Estágio 4
Pelos do tipo adulto, encaracolados, mais distribuídos, e ainda em pouca quantidade. (P4)



Estágio 5
Pelos tipo adulto, com maior distribuição na região pubiana, e na raiz da coxa. (P5)

11. Coluna e membros:

- Coluna:
- Teste de Adams:
- Pregas glúteas e das costas simétricas
- Tônus muscular adequado?
 - Palpação:
 - puxar o bebê pelos braços para tes

- Sinais de displasia de quadril ou alteração na
- Manobra de Barlow e Ortolani
 - Até 3 meses
- Membros:
- Marcha:
- Fossetas sacrais?

- lo de braços para testar o tônus do
- Genu varum (alicate)? Genu valgum?
 - Desaparecem por volta de 4 a 5 an
- Mancha mongólica?
- Manchas café com leite?

12. Reflexos

- Marcha (2 meses);
- Busca (3 meses);
- Moro (6 meses);
- Preensão palmar (6 meses);
- Esgrimista (6 meses);
- Galant (6 meses);
- Preensão plantar (12 meses);
- Babinski (extensão no cutâneo-plantar) (2 anos);

Acervo Geral:

Escala de Bistrol

ESCALA DE BRISTOL

Tipo 1 Pequenos fragmentos duros, semelhantes a nozes.



Tipo 2 Em forma de salsicha, mas com grumos.



Tipo 3 Em forma de salsicha, com fissuras à superfície.



Tipo 4 Em forma de salsicha ou cobra (mais finas), mas suaves e macias.



Tipo 5 Fezes fragmentadas, mas em pedaços com contornos bem definidos e macias.



Tipo 6 Em pedaços esfarrapados.



Tipo 7 Líquidas.



Escore Apgar

	0	1	2
Esforço respiratório	Ausente	Lento ou irregular	Bom, chorando
Frequência cardíaca	Ausente	<100 bpm	> 100 bpm
Tônus muscular	Flácido	Flexão de extremidades	Ativo
Irritabilidade reflexa	Sem reação	Alguma reação	Choro, tosse, espirro
Cor	Cianose central ou pálido	Cianose de extremidades	Róseo

Z-Scores esperados:

a) PESO:

- **Muito Baixo Peso para a Idade:** Z-score < -3
- **Baixo Peso para a Idade:** Z-score entre -3 e -2
- **Peso Adequado para a Idade (Eutrofia):** Z-score entre -2 e +2
- **Peso Elevado para a Idade:** Z-score > +2

b) ESTATURA:

- Estatura muito elevada (raro) **acima de +3**
- Estatura elevada para a idade **acima +2**
- Estatura adequada para a idade **entre -2 e +2**
- Baixa estatura para a idade **entre -2 e -3**
- Muito baixa estatura para a idade **abaixo de -3**

c) IMC

Classificação	Faixa Etária: < 5 anos	Faixa Etária: 5 a 19 anos
Obesidade Grave	N/A	acima de +3

Classificação	Faixa Etária: < 5 anos	Faixa Etária: 5 a 19 anos
Obesidade	acima de +3	entre +2 e +3
Sobrepeso	entre +2 e +3	entre +1 e +2
Risco de Sobrepeso	entre +1 e +2	N/A
Eutrofia (Peso Adequado)	entre -2 e +1	entre -2 e +1
Magreza (Baixo Peso)	entre -3 e -2	entre -3 e -2
Magreza Acentuada	abaixo de -3	abaixo de -3

Classificação do RN quanto à IG

- **Pré-termo:** Menos de 37 semanas completas.
 - **Extremo:** < 28 semanas
 - **Muito pré-termo:** 28 a < 32 semanas
 - **Moderado a tardio:** 32 a < 37 semanas
- **Termo:** 37 a 41 semanas e 6 dias.
 - **Termo precoce:** 37 a 38 semanas e 6 dias.
 - **Termo completo:** 39 a 40 semanas e 6 dias.
 - **Termo tardio:** 41 a 41 semanas e 6 dias.
- **Pós-termo:** 42 semanas ou mais.

Classificação do RN quanto ao peso ao nascer:

- **Extremo Baixo Peso:** Menor que 1.000 gramas.
- **Muito Baixo Peso:** Menor que 1.500 gramas.
- **Baixo Peso:** Menor que 2.500 gramas.
- **Peso Insuficiente:** Entre 2.500g e 2.999g.
- **Peso Normal/Adequado:** Entre 2.500g e 3.999g.
- **Macrossomia (Peso Elevado):** Maior que 4.000 gramas.
- **Tamanho Excessivamente Grande:** 4.500g ou mais.

Marcos do DNPM por idade

- 2-4 meses
 - Acompanha objetos com o olhar
 - Interage com a mãe pelo olhar

- Sorriso social
- 3 a 6 meses
 - Brinca de faz de conta
- 4 meses
 - Sustenta a cabeça
 - Já emite alguns sons
- 6 meses
 - Localiza estímulo auditivo
 - Fica sentado com apoio
- 9 meses
 - Fica sentado sem apoio
 - Engatinha
- 11 meses
 - Anda com apoio
- 12 a 18 meses:
 - Iniciou a fala? Quantas palavras?
- 15 meses:
 - Anda sem apoio
- Olhar a caderneta da criança.

Sinais de Alerta no DNPM

Instrumento de Avaliação do Desenvolvimento Integral da Criança

DADOS DE AVALIAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA
Perímetro cefálico < -2Z escores ou > +2Z escores; ou Presença de 3 ou mais alterações fenotípicas*; ou Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a faixa etária anterior (se a criança estiver na faixa de 0 a 1 mês, considere a ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária suficiente para esta classificação).	PROVÁVEL ATRASO NO DESENVOLVIMENTO	• Acionar a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento.
Ausência de 1 ou mais reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária (de 1 mês a 6 anos). ou Todos os reflexos/posturas/habilidades para a sua faixa etária estão presentes, mas existe 1 ou mais fatores de risco.	ALERTA PARA O DESENVOLVIMENTO	• Orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da criança. • Marcar consulta de retorno em 30 dias. Informar a mãe/cuidador sobre os sinais de alerta para retornar antes de 30 dias.
Todos os reflexos/posturas/habilidades presentes para a sua faixa etária.	DESENVOLVIMENTO ADEQUADO	• Elogiar a mãe/cuidador. • Orientar a mãe/cuidador para que continue estimulando a criança. • Retornar para acompanhamento conforme a rotina do serviço de saúde. • Informar a mãe/cuidador sobre os sinais de alerta para retornar antes.

Ganho de peso no 1º ano:

- 1º trimestre → 700g/mês;
- 2º trimestre → 600g/mês;
- 3º trimestre → 500g/mês;
- 4º trimestre → 400g/mês;

Aumento de PC no 1º ano:

- 1º trimestre → 2cm/mês;
- 2º trimestre → 1cm/mês;
- 3º trimestre → 0,5cm/mês;
- 4º trimestre → 0,5/mês;

Reflexos Primitivos:

Reflexo	Idade	Estímulo	Resposta	Imagem
Reflexo de Moro	0 - 4 meses	Barulho súbito, puxar o lençol em que o bebê está deitado (dar susto)	O bebê joga a cabeça para trás, estende os braços e as pernas, chora e depois puxa os braços e as pernas para dentro.	
Reflexo de sucção	0 - 3/5 meses	Tocar os lábios e a parte interna da boca.	Movimentos rítmicos, língua em cácula, movimentos orofaciais (movimento de sucção)	
Reflexo de preensão palmar	0 - 4/5 meses	Realiza preensão na região palmar.	Flexão dos dedos.	
Reflexo de preensão plantar	0 - 9/12 meses	Realizar preensão na face plantar dos pés do bebê na região distal dos metatarsos.	Flexão dos dedos dos pés	
Reflexo de apoio positivo	0 - 1/2 meses	Apolar o calcanhar em superfície plana e rígida.	Extensão dos MM.II. (posição de pé)	
Reflexo de busca	0 - 3 meses	Tocar região perioral quando o bebê está com fome	Virar a cabeça e os lábios na direção do estímulo	

Prescrições Comuns:

- Consulta com Oftalmologista;
- Consulta com Dentista: toda criança com algum dente crescendo precisa ir ao dentista;
- Avaliação com fisioterapeuta: importante se a criança apresenta atraso motor;
- Avaliação com fonoaudiólogo: importante se a criança apresenta atraso na linguagem;
- Ferro e vitamina D.